

HFpEF po 50-tce: objawy, diagnostyka i aktualne leczenie



Szybka odpowiedź

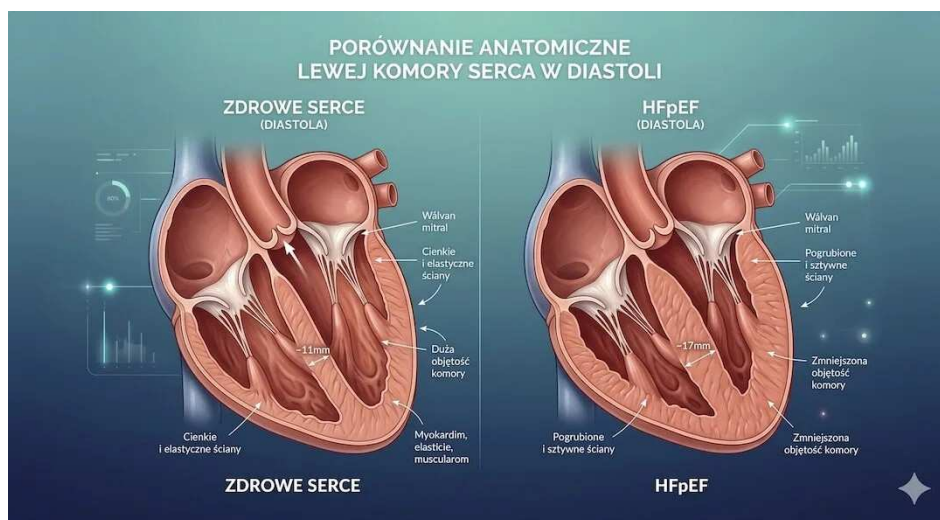
HFpEF oznacza objawy niewydolności serca przy frakcji wyrzutowej lewej komory co najmniej 50% oraz dowodach podwyższonych ciśnień napełniania. Prawidłowa frakcja wyrzutowa nie wyklucza choroby. Nowa duszność, obrzęki lub spadek tolerancji wysiłku wymagają oceny lekarskiej, a nagła duszność w spoczynku — pilnej pomocy. Samo echo spoczynkowe może nie wystarczyć.

Kluczowe wnioski

- Samo EF $\geq 50\%$ nie rozpoznaje ani nie wyklucza HFpEF.
- Diagnostyka łączy objawy, badanie, echo, EKG, peptydy natriuretyczne i czasem test wysiłkowy lub hemodynamiczny.
- Leczenie obejmuje kontrolę zastoju i chorób współistniejących; inhibitory SGLT2 zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca u odpowiednich pacjentów.
- Ćwiczenia w stabilnej chorobie powinny być dobrane po ocenie medycznej, a nie według uniwersalnej liczby sesji.

Dlaczego prawidłowa frakcja wyrzutowa nie zamyka diagnostyki?

Frakcja wyrzutowa opisuje odsetek krwi wyrzucanej z lewej komory podczas skurczu. W HFpEF wynosi co najmniej 50%, ale serce może napełniać się pod zbyt wysokim ciśnieniem, zwłaszcza podczas wysiłku. Dlatego wynik „EF 60%” nie oznacza automatycznie, że przyczyna duszności leży poza sercem.



Frakcja wyrzutowa opisuje odsetek krwi wyrzucanej z lewej komory podczas skurczu.

Rozpoznanie wymaga objawów lub cech niewydolności oraz obiektywnych dowodów nieprawidłowych ciśnień napełniania. Echo ocenia znacznie więcej niż EF. Więcej o kontroli ryzyka przeczytasz w [przewodniku badań po 50-tce](#).

Jakie objawy i sygnały alarmowe wymagają reakcji?

Typowe są duszność wysiłkowa, mniejsza tolerancja ruchu, obrzęki nóg i duszność przy leżeniu, ale te objawy mają również inne przyczyny. Nagła duszność w spoczynku, ból w klatce, omdlenie, sinienie lub gwałtowne pogorszenie wymagają pilnej pomocy medycznej.



Typowe są duszność wysiłkowa, mniejsza tolerancja ruchu, obrzęki nóg i duszność przy leżeniu, ale te objawy mają również inne przyczyny.

Osoba z rozpoznaną niewydolnością powinna mieć indywidualny plan reagowania na przyrost masy i obrzęki. Popularny próg dwóch kilogramów nie zastępuje zaleceń prowadzącego zespołu. Ciśnienie i ryzyko opisuje [Centrum Nadciśnienia po 50-tce](#).

Jak lekarz potwierdza lub wyklucza HFpEF?

Ocena zwykle obejmuje wywiad, badanie, EKG, echo i BNP lub NT-proBNP oraz poszukiwanie innych przyczyn duszności. Otyłość może obniżać stężenie peptydów natriuretycznych, a migotanie przedsionków i choroba nerek je podwyższają, dlatego pojedynczy wynik nie działa jak prosty test tak–nie.



Ocena zwykle obejmuje wywiad, badanie, EKG, echo i BNP lub NT-proBNP oraz poszukiwanie innych przyczyn duszności.

W niejednoznacznych przypadkach stosuje się skale H2FPEF lub HFA-PEFF, echo wysiłkowe albo inwazyjny pomiar hemodynamiczny. Trzeba też rozważyć chorobę płuc, niedokrwistość, choroby zastawek i inne kardiomiopatie. Wyniki krwi opisujemy w [poradniku badań laboratoryjnych](#).

Jak obecnie leczy się HFpEF?

Leczenie dobiera się do zastój, ciśnienia, rytmu serca, funkcji nerek, cukrzycy, masy ciała i innych chorób. Diuretyki łagodzą zastój, a inhibitory SGLT2 mają w wytycznych mocne miejsce ze względu na zmniejszenie ryzyka zdarzeń związanych z niewydolnością serca. Leki wymagają recepty i kontroli działań niepożądanych.



Leczenie dobiera się do zastój, ciśnienia, rytmu serca, funkcji nerek, cukrzycy, masy ciała i innych chorób.

U stabilnych pacjentów rehabilitacja i regularna aktywność mogą poprawiać tolerancję wysiłku oraz jakość życia. Program powinien uwzględniać objawy i leczenie; uniwersalne „4–5 treningów” nie jest bezpiecznym zaleceniem dla każdego. Bezpieczny powrót do ruchu omawia [przewodnik FitPo50](#).

HFpEF: co oznacza wynik, a czego nie przesądza

Element	Co wnosi	Ważne ograniczenie
EF $\geq 50\%$	Spełnia kryterium zachowanej frakcji	Nie wystarcza do rozpoznania
BNP lub NT-proBNP	Wspiera ocenę przeciążenia serca	Wpływają na nie otyłość, rytm i nerki
Echo	Ocenia strukturę i funkcję serca	W spoczynku wynik może być niejednoznaczny
Test wysiłkowy/hemodynamika	Może ujawnić wzrost ciśnień przy wysiłku	Wymaga kwalifikacji specjalisty

Najczęściej zadawane pytania

Czy prawidłowe EF wyklucza niewydolność serca?

Nie. W HFpEF frakcja wyrzutowa wynosi co najmniej 50%, ale występują objawy i dowody podwyższonych ciśnień napęnlania.

Czy samo echo rozpoznaje HFpEF?

Nie zawsze. Lekarz łączy objawy, echo, peptydy natriuretyczne i inne badania, a czasem zleca ocenę wysiłkową.

Jakie objawy są alarmowe?

Nagła duszność w spoczynku, ból w klatce, omdlenie lub sinienie wymagają pilnej pomocy medycznej.

Czy z HFpEF można ćwiczyć?

W stabilnej chorobie ruch może pomagać, ale rodzaj i intensywność powinny uwzględniać ocenę lekarza i aktualne objawy.

Pomiary domowe, ruch, dieta DASH i zasady bezpiecznego treningu znajdziesz w [Centrum Nadciśnienia po 50-tce](#).

Źródła

1. [AHA/ACC/HFSA — Guideline for the Management of Heart Failure](#)
2. [ESC — 2023 Focused Update on Heart Failure](#)
3. [ACC — 2023 Expert Consensus Decision Pathway on HFpEF](#)
4. [ESC — Heart Failure Guidelines](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.